

頭頸部惡性腫瘤手術說明書

這份說明書是有關您即將接受的手術（或醫療處置）的效益、風險及替代方案的書面說明，可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還有對這個手術（或醫療處置）的任何疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為了您的健康努力。

適應症及作法：（簡述）

頭頸部惡性腫瘤(癌症)，除對週邊組織有嚴重的侵犯能力，更可能轉移至頸部、肺部、肝臟、骨骼等進而危害生命安全。因此若能即時施以廣泛性手術切除治療，可以拯救生命，免除癌症帶來的痛苦。

效益：（經由手術，您可能獲得以下的效益，但醫師並不能保證您一定能夠獲得其中的任何一項；手術效益與風險性間的取捨，應由您決定。）

經由手術，您可能獲得以下所列的效益，但醫師並不能保證獲得任何一項；且手術效益與風險性間的取捨，應由您決定。經由上述手術之施行，您可能獲得以下所列部分或全部的效益：（1）手術切除，防止癌細胞的擴散、組織破壞和進一步的全身轉移。（2）拯救生命，減少或免除癌症帶來的痛苦及組織器官功能的喪失。（3）手術處置成功率。

風險：（沒有任何手術或醫療處置是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是可能仍然有一些醫師無法預期的風險未被列出。）

沒有任何手術是完全沒有風險的，這些風險包括術中、術後可能之暫時或永久性併發症。頭頸部惡性腫瘤切除是一個大手術，這些併發症，嚴重時甚至可能威脅生命。以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。醫師將會為您解釋這些可能產生的風險及處理方式。

（一）一般性併發症（1）傷口出血。（2）傷口疼痛、腫脹。（3）傷口感染、癒合不良或組織壞死。（4）局部或全身麻醉風險。（5）因併發症或手術效果不如預期，必要時需再度手術。（6）必要時輸血導致之不適感或感染風險（如愛滋病、肝炎等）。（如果您曾接受手術部位放射線治療、正接受或剛接受完化學治療、長期服用免疫抑制劑或抗排斥藥、或有營養不良、血液方面疾病、糖尿病、尿毒症、肝功能異常、惡性腫瘤或其他引起抵抗病菌能力降低的疾病等，會提高術後傷口感染機會；如果您正接受或剛接受完化學治療、長期服用抗凝血藥、或有糖尿病、尿毒症、肝功能不良、引起血液凝固降低的疾病等，會提高出血的機會；如果您年紀超過60歲、嚴重貧血、患有心肺方面疾病或功能不佳等，會提高麻醉的風險。）

(二)特殊性併發症

(1)術中大出血。

(2)術中發現癌細胞與大動脈緊密沾黏無法剝離，迫使手術中止。

(3)呼吸道阻塞須施以氣管切開術。

(4)全身性感染或敗血症。

(5)氣胸、呼吸困難、肺炎、肺擴張不全。

(6)顏面神經傷害導致眼睛暫時或永久性閉合不全或嘴角歪斜。

(7)三叉神經傷害導致顏面、嘴唇、下頷、牙齒或舌頭暫時或永久性麻痺感。(8)術後頭痛、頸部酸痛或神經傳導障礙。

(9)肩部無力、上臂無法舉起、頸部轉動困難。

(10)口唇閉合不全。

(11)疤痕癢縮導致開口困難。

(12)頭頸部組織缺損導致顏面外觀改變或醜型疤痕形成，必要時需進行同階段或第二階段整形重建手術。

(13)言語、咀嚼、咬合或吞嚥等功能障礙。

(14)口、鼻竇、鼻腔相通，導致鼻音產生及飲水嗆鼻，可能需製作活動假牙、填塞器或皮瓣修補。

(15)頸部乳糜管瘻管。

(17)耳後疼痛。

(18)口水分泌減少。

(19)癌症復發。

(20)聲音沙啞。(21)頸動脈暴露。

(22)缺血性中風。

(23)長期上下顎間固定，口腔清潔不易，導致牙齒牙周炎或蛀牙

替代方案：如果您決定不施行這個手術或醫療處置，可能會有危險，請與醫師討論您的決定。這個手術或醫療處置的替代方案如下：

手術切除仍是最好的選擇，否則腫瘤範圍日益擴大，可能侵犯到周圍或遠處的組織器官，造成生命威脅。如果您決定不施行這個手術，這個手術的替代方案如下：

1. 不接受治療。
2. 放射線治療。
3. 化學治療。
4. 門診追蹤。

醫師補充說明/病人提出之疑問及解釋:(如無，請填寫無)

1. 檢體作為醫學研究之用。
2. 手術時間。
3. 術後加護病房。
4. 呼吸方式的改變（如氣管切開術等）。
5. 開口方式的改變（如上下顎間固定等）。
6. 進食方式的改變（如胃造瘻或鼻胃管進食等）。
7. 住院天數。
8. 住院費用(如健保部分負擔、健保病房費差額、自費醫材、藥物或手術項目等)。
9. 其它術後注意事項。
10. 手術後癌症存活率。

許多的頭頸部癌症病人經過正規的醫學治療(包括手術、放射線治療或化學治療)後，得到痊癒的效果。但根據過去的統計，治療後也有高達 40%以上的復發率，甚至導致死亡。醫師不能保證您接受手術後，可以得到最好的結果，甚至癌症不再復發。以下的因素會影響您癌症治療的效果：

- (1)年紀。
- (2)營養及免疫狀態。
- (3)合併有其它全身性系統疾病。
- (4)腫瘤的部位。
- (5)腫瘤的大小。
- (6)是否有頸部淋巴結轉移。
- (7)是否有遠處器官轉移（如肺、肝、骨頭、腦部等）。

(8)是否接受標準之大範圍腫瘤切除及淋巴廓清術手術療法。

(9)是否接受其它合併療法（如放射線治療或化學治療）。

(10)術後是否定期回診。

(11)術前是否有抽菸、喝酒、嚼食檳榔等不良口腔習慣。

(12)術後是否完全戒除抽菸、喝酒、嚼食檳榔等不良口腔習慣。

(13)術後是否移除或換新會造成口腔黏膜刺激之口內不良假牙及補綴物。

醫師已提供頭頸部惡性腫瘤手術說明暨同意書供病人參考，且病人對於醫師的說明均充份了解。

頭頸部惡性腫瘤手術同意書

一、 擬實施之手術（如醫學名詞不清楚，請加上簡要解釋）

1. 疾病名稱： 口腔惡性腫瘤

2. 建議手術名稱：

頸部淋巴擴清術(雙側上或全頸部)，腫瘤廣泛性切除術(口底及舌部分切除術) 合併下顎骨部分切除術，視情況下唇及皮膚切除，拔牙(18, 28, 12, 11, 21, 22, 23, 37, 38 , 47, 48)，氣管切開術；施行下顎骨金屬骨板重建。

3. 建議手術原因： 治療癌症

二、 醫師之聲明

1. 我已經儘量以病人所能瞭解之方式，解釋這項手術之相關資訊，特別是下列事項：

■需實施手術之原因、手術步驟與範圍、手術之風險及成功率、輸血之可能性。

■手術併發症及可能處理方式。

■不實施手術可能之後果及其他可替代之治療方式。

■預期手術後，可能出現之暫時或永久症狀。

■其他與手術相關說明資料，已交付病人。

2. 我已經給予病人充足時間，詢問下列有關本次手術的問題，並給予答覆：

手術風險：出血、感染、肺炎、心肺急症、呼吸道阻塞、敗血症、肺栓塞等，嚴重時可能威脅生命。手術死亡率約 1-3%。其它可能手術副作用：下唇及舌暫時或長期麻木感、鼻竇炎、口鼻竇或口鼻相通、口腔皮膚相通、鄰牙傷害、斷根殘留或異位(鼻竇或口底)、病變復發、吞嚥、言語、開閉口、咀嚼、舌運動功能、肩頸上臂運動、顏面表情、顏面感覺(麻

木或疼痛)、視力或眼球運動功能暫時或永久功能障礙、開閉口疼痛、關節障礙、開口度降低、下顎開口偏移、嘴角閉合不全漏涎、口角、唇或鄰近黏膜皮膚外傷、疤痕增生、顎骨壞死、金屬骨板或骨釘露出感染斷裂鬆脫而需移除、咬合不正、顏面外觀不對稱、顏面凹陷外觀、長期需鼻胃管進食或胃造瘻進食、下顎骨折、皮瓣壞死等風險。術後傷口癒合緩慢或不良可能需長期照顧或再手術等風險、癌症五年存活率視期別不同從第一期之 80-90% 至第四期之 30-40%。

三、 病人之聲明

1. 醫師已向我解釋，並且我已經瞭解施行這個手術的必要性、步驟、風險、成功率之相關資訊。
2. 醫師已向我解釋，並且我已經瞭解選擇其他治療方式之風險。
3. 醫師已向我解釋，並且我已經瞭解手術可能預後情況和不進行手術的風險。
4. 我瞭解這個手術必要時可能會輸血：我 ☒ 同意 ☐ 不同意輸血。
5. 針對我的情況、手術之進行、治療方式等，我能夠向醫師提出問題和疑慮，並已獲得說明。
6. 我瞭解在手術過程中，如果因治療之必要而切除器官或組織，醫院可能會將它們保留一段時間進行檢查報告或供日後研究之用，並且在之後會謹慎依法處理。
7. 我瞭解這個手術有一定的風險，無法保證一定能改善病情。

附註：

一、 手術的一般風險

1. 手術後，肺臟可能會有一小部份塌陷失去功能，以致增加胸腔感染的機率，此時可能需要
2. 抗生素和呼吸治療或其他必要的治療。
3. 除局部麻醉以外之手術，腿部可能產生血管栓塞，並伴隨疼痛和腫脹。凝結之血塊可能會
4. 分散並進入肺臟，造成致命的危險，惟此種情況並不常見。
5. 因心臟承受壓力，可能造成心臟病發作，也可能造成中風。
6. 手術過程仍可能發生難以預期的意外，甚至因而造成死亡。

二、 立同意書人非病人本人者，「與病人之關係欄」應予填載與病人之關係。

三、 手術同意書除下列情形外，應由病人親自簽名：

1. 病人為未成年人或因故無法為同意之表示時，得由法定代理人、配偶、親屬或關係人簽名。

2. 病人之關係人，係指與病人有特別密切關係之人，如伴侶(不分性別)、同居人、摯友等；或依法令或契約關係，對病人負有保護義務之人，如監護人、少年保護官、學校教職員、肇事駕駛人、軍警消防人員等。

3. 病人不識字，得以按指印代替簽名，惟應有二名見證人於指印旁簽名。

四、 醫療機構應於病人簽具手術同意書後三個月內，施行手術，逾期應重新簽具同意書，簽具手術同意書後病情發生變化者，亦同。

五、 手術進行時，如發現建議手術項目或範圍有所變更，當病人之意識於清醒狀態下，仍應予告知，並獲得同意，如病人意識不清醒或無法表達其意思者，則應由病人之法定或指定代理人、配偶、親屬或關係人代為同意。無前揭人員在場時，手術醫師為謀求病人之最大利益，得依其專業判斷為病人決定之，惟不得違反病人明示或可得推知之意思。

六、 醫療機構為病人施行手術後，如有再度為病人施行手術之必要者，仍應重新簽具同意書。

七、 醫療機構查核同意書簽具完整後，一份由醫療機構連同病歷保存，一份交由病友收執。

八、 見證人部分，如無見證人得免填載。